SDD 69 Sujet n°1

Spécialité : Cardiologie

Date : 05/01/2025
Auteurs : Razvan BICA (DES psychiatrie, EN 2024), Camille MARTINAUD (DES psychiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Education, prévention
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	Item 330 - Prescription des classes médicamenteuses les plus courantes
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 248 - Prescription d'un traitement par anticoagulant
Matériel nécessaire à la station	Deux tables, une chaise
Contexte de la station	Consultation de médecine générale

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste et vous recevez en consultation Monsieur SABAVITE 85 ans.
Il consulte suite à son hospitalisation il y a un mois en cardiologie après un épisode de malaise. Un rétrécissement aortique a été diagnostiqué, qui a été traité par valve mécanique. Le patient a été mis sous warfarine.
Il vient vous voir en consultation de suivi habituelle et souhaite vous parler de son nouveau traitement qu'il ne comprend pas très bien.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Réaliser l'éducation thérapeutique vis-à-vis du traitement
- Initier un suivi pour ce traitement et prescrire si nécessaire des examens complémentaires

Vous ne devez pas :

- Expliquer la suite de sa prise en charge cardiologique
- Évoquer d'autres médicaments

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Explique **l'objectif du traitement**, au moins **un élément parmi les suivants** : "fluidifie le sang", "éviter la formation de caillots"	1 pt
2.	Explique qu'il s'agit d'un traitement à prendre **oralement** (*ou "par la bouche, "comprimé")* ET **une fois par jour**.	1 pt
3.	Evalue l'**observance** OU évoque la nécessité de prendre le traitement **tous les jours**.	1 pt
3.	Explique que ce traitement est à risque de **saignements**.	1 pt
4.	Cite au moins **deux signes devant amener à consulter en urgence** : hématome, épistaxis, sang dans les selles, hémoptysie, hématémèse, saignement gingival, bulles hémorragiques	1 pt
6.	Évoque la nécessité de prévenir tout médecin de ce traitement au long cours	1 pt
7.	Évoque la nécessité d'éviter les automédications (risque d'interaction)	1 pt
8.	Évoque l'un des éléments suivants : - **carnet** de surveillance de l'INR - **carte** "patient sous anticoagulant"	1 pt
9.	Explique la nécessité de réaliser **des prises de sang régulières** *(contrôle de l'INR)*.	1 pt
10.	Explique que le seuil d'INR cible se situe **entre 2 et 3**.	1 pt
11.	Explique que le traitement sera à prendre à vie	1 pt
12.	Explique que les doses de médicaments seront modulés selon les résultats de l'INR ou des prises de sang	1 pt
Communications et attitudes		

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**14 points**

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste et vous recevez en consultation Monsieur SABAVITE 85 ans.
Il consulte suite à son hospitalisation il y a un mois en cardiologie après un épisode de malaise. Une embolie pulmonaire a été mise en évidence. Le patient a été mis sous warfarine.
Il vient vous voir en consultation de suivi habituelle et souhaite vous parler de son nouveau traitement qu'il ne comprend pas très bien.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Réaliser l'éducation thérapeutique vis-à-vis du traitement
- Initier un suivi pour ce traitement et prescrire si nécessaire des examens complémentaires

Plan de la station ECOS :

Patient et médecin face à face séparé par une table

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, je viens vous voir parce qu'on m'a donné un nouveau traitement pour mon embolie pulmonaire à la sortie de l'hôpital, j'avoue que je ne comprends pas très bien à quoi il sert et si je dois le garder…

Identité du patient :

M. S, 85 ans

Mode de vie :

Retraité, ancien ingénieur informatique
Marié, vit avec sa femme, 2 enfants de 35 et 43 ans
Autonome dans la vie quotidienne

Comportement global :

Perplexe vis-à-vis du nouveau traitement et ce qu'il implique.

Antécédents personnels :

- Hypertension artérielle
- Dépression

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

- perindopril 2.5 mg/j
- paroxétine 20 mg/j

Symptômes positifs :

0

Questions de relance :

- Si l'étudiant(e) n'a évoqué le suivi par INR/prise de sang au bout de 7 minutes, demander : mais du coup je dois revenir vous voir bientôt et faire des examens supplémentaires ?